

10A. Dolor nociplástico: anamnesis dirigida

Reconocer un fenotipo de procesamiento alterado sin convertirlo en diagnóstico de exclusión ni en 'dolor psicológico'.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿El dolor dura más de tres meses y se ha extendido a varias zonas o cambia mucho de localización?	Distribución regional/generalizada compatible con fenotipo nociplástico.	Reduce patrón generalizado; no excluye nociplástico regional.	Mapa corporal, WPI/SSS y búsqueda de generadores locales.
¿Le duele el roce, una presión leve o estímulos que antes no dolían?	Alodinia/hiperalgesia e hipersensibilidad.	No excluye nociplástico; puede faltar.	Comparación táctil, pinprick y presión en zonas locales/remotas.
¿El dolor parece mucho mayor o más persistente de lo esperado por la lesión o la imagen?	Desacople clínico que aumenta plausibilidad nociplástica.	Mayor concordancia periférica; no excluye coexistencia.	Revisar concordancia de imagen, función y respuesta a tratamientos locales.
¿Duerme mal, se levanta sin descanso o tiene fatiga y niebla mental?	Carga multisistémica frecuente en fibromialgia/nociplástico.	Reduce esa carga, pero no excluye el mecanismo.	WPI/SSS, sueño, apnea/RLS, medicación y función.
¿También tiene cefalea, intestino irritable o sensibilidad marcada a luz, ruido u olores?	Comorbilidades que aumentan plausibilidad.	No excluye; no son obligatorias.	Historia multisistémica sin atribuir automáticamente todo al dolor.
¿Los bloqueos o tratamientos locales han dado respuestas breves, variables o desproporcionadas?	El generador periférico puede no explicar todo el cuadro.	Respuesta local reproducible apoya componente periférico coexistente.	Revisar tareas antes/después y evitar escalar por hallazgos incidentales.
¿Hay quemazón, descargas, déficit focal, rigidez inflamatoria, fiebre o pérdida de peso?	Neuropatía, inflamación o bandera roja que puede coexistir y debe priorizarse.	Reduce esos imitadores, sin confirmar nociplástico.	Neurología, DN4/painDETECT y estudio dirigido según sospecha.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

No existe una pregunta ni un test confirmatorio aislado. El fenotipo se apoya en duración, distribución, hipersensibilidad y síntomas asociados tras valorar mecanismos nociceptivos, inflamatorios y neuropáticos.

10B. Dolor nociplástico: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Mapa + WPI/SSS	Marcar todas las zonas dolorosas y puntuar extensión, fatiga, sueño y síntomas cognitivos.	Dolor generalizado y carga sintomática alta apoyan fibromialgia/fenotipo nociplástico tras excluir imitadores.	Puntuación baja reduce fibromialgia generalizada, no excluye nociplástico regional.
Alodinia táctil	Rozar piel con algodón/cepillo suave en área dolorosa, contralateral y zona distante.	Dolor ante estímulo inocuo, sobre todo extendido: apoya hipersensibilidad; también puede ser neuropática.	No excluye nociplástico; muchos pacientes no presentan alodinia.
Pinprick / hiperalgesia	Comparar pinchazo romo estandarizado en lados y zonas distantes, sin lesionar piel.	Respuesta desproporcionada o extendida: apoya amplificación, pero una distribución neural sugiere neuropatía.	No excluye sensibilización; la respuesta depende de contexto y técnica.
Presión comparativa	Aplicar presión gradual similar en punto doloroso, contralateral y zona remota; detener al primer dolor.	Umbral bajo generalizado apoya hipersensibilidad difusa; focal puede reflejar lesión local.	No excluye nociplástico y no sustituye algometría/QST formal.
Exploración neurológica	Fuerza, reflejos, sensibilidad, coordinación y marcha según territorio clínico.	Déficit focal/dermatómico obliga a priorizar neuropatía, raíz o médula, aunque pueda coexistir nociplástico.	Normal reduce lesión neurológica objetiva, pero no confirma nociplástico.
DN4 / painDETECT	Cuestionario más exploración breve para rasgos neuropáticos cuando hay quemazón, descargas o alodinia.	Cribado positivo apoya componente neuropático; no demuestra lesión ni excluye coexistencia nociplástica.	Reduce componente neuropático, no lo elimina ni diagnostica nociplástico.
CSI	Cuestionario de síntomas relacionados con sensibilización y comorbilidades.	Puntuación alta abre conversación sobre carga multisistémica; no es biomarcador ni diagnóstico.	Puntuación baja no excluye nociplástico; usar solo como apoyo.

SÍNTESIS CLÍNICA

No existe un 'test positivo de dolor nociplástico'. El diagnóstico es fenotípico: dolor >3 meses, distribución/hipersensibilidad y comorbilidades, con evaluación suficiente de generadores nociceptivos, inflamatorios y neuropáticos. Un hallazgo local puede coexistir.

10C. Dolor nociplástico: tratamiento y seguimiento

La prioridad es reducir amenaza, recuperar función y mejorar autorregulación. Los procedimientos repetidos sobre hallazgos incidentales suelen empeorar la iatrogenia.

Componente	Intervención	Dosificación inicial
Educación	Explicar mecanismos, seguridad del movimiento y plan compartido	Mensajes breves y repetidos; evitar 'todo está en su cabeza'.
Ejercicio	Aeróbico, fuerza y movilidad graduados según tolerancia	Inicio bajo, 2-3 días/semana; progresar tiempo o carga, no ambos a la vez.
Sueño y ritmo	Horario, luz, actividad, tratamiento de apnea/RLS si sospecha	Pacing flexible: evitar ciclos auge-caída y reposo total.
Psicoterapia	CBT o ACT centrada en dolor y función	Integrarla como tratamiento del sistema de dolor, no como descarte.
Fármacos	Duloxetina o amitriptilina seleccionadas; revisar beneficio funcional	Una variable cada vez; retirar si no hay beneficio. Evitar opioides crónicos.
Multidisciplinar	Dolor, AP, fisio, psicología y trabajo/social según impacto	Indicar cuando hay alta discapacidad, comorbilidad o fracaso fragmentado.

Procedimiento / modalidad	Papel
Bloqueos e infiltraciones	No diagnostican nociplástico. Usar solo si existe generador periférico concordante y el resultado cambiará una conducta concreta.
Ecografía / RM	No hay plantilla diagnóstica. Evitar perseguir hallazgos degenerativos incidentales.
ESWT / EMTT / inductiva	No son tratamiento central del fenotipo; solo para una lesión periférica bien definida, con expectativas realistas.

SEGUIMIENTO	Revisar cada 4-8 semanas al inicio: sueño, pasos/actividad, tarea elegida, participación, miedo y medicación. Una reducción de dolor modesta puede ser éxito si mejora función y autonomía.
--------------------	---

MENSAJE AL PACIENTE	Su dolor es real. El sistema que lo produce se ha vuelto demasiado sensible. No buscamos una lesión oculta en cada zona, sino bajar esa sensibilidad y recuperar poco a poco sueño, confianza, fuerza y vida diaria.
----------------------------	--

10D. Dolor nociplástico: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Primera opción	Duloxetina 30 mg/día durante 1-2 semanas; después 60 mg/día si tolera.	Ensayo 6-8 semanas; continuar solo con beneficio funcional. Retirada gradual 2-4 semanas.
Alternativa nocturna	Amitriptilina 10 mg por la noche; subir 10 mg cada 7 días hasta 25-50 mg según tolerancia.	Valorar a 4-8 semanas; reducir gradualmente al suspender.
Dolor local coexistente	Paracetamol o AINE solo por generador nociceptivo periférico concordante, no para el fenotipo global.	Curso breve de 3-7 días.
No ofrecer de rutina	Opioides, gabapentinoides, benzodiacepinas, corticoides o combinaciones sedantes para dolor crónico primario.	Revisar y deprescribir de forma gradual cuando proceda.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Bloqueo 'nociplástico'	No existe fármaco ni volumen diagnóstico.	No realizar.
Generador periférico coexistente	Usar el injectate específico de esa ficha solo si clínica y tarea son concordantes.	Menor volumen eficaz; un resultado negativo obliga a revisar, no a repetir.
Puntos gatillo	Si indicación miofascial clara: lidocaína 0,5-1%, sin corticoide.	0,5-1 mL por punto; limitar número y dosis total; evidencia modesta.

REHABILITACIÓN

Ejercicio aeróbico y fuerza con inicio bajo 2-3 días/semana, sueño, pacing, CBT/ACT y plan multidisciplinar; revisión cada 4-8 semanas.

EVITAR

Escalada de infiltraciones por hallazgos incidentales, combinar duloxetina y amitriptilina de entrada, perseguir EVA cero o interpretar el dolor como psicológico.